Seguro Integral de Salud

Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones

Criterios Técnicos para el Registro Modular por Curso de Vida (RM-CV) en el Formato Único de Atención (FUA).

Códigos de servicio:

301 Cuidado Integral por curso de vida del niño.

302 Cuidado Integral por curso de vida del adolescente.

303 Cuidado Integral por curso de vida del joven.

304 Cuidado Integral por curso de vida del adulto.

305 Cuidado Integral por curso de vida del adulto mayor

306 Cuidado Integral de la salud pre natal.

23 DE FEBRERO 2026

Zulma Anaya Chacón
Jefa del Seguro Integral de Salud.

Pedro Alejandro Cruzado Puente
Jefe adjunto

Wilder Vidauro Carpio Montenegro
Gerente de Riesgos y Evaluación de Prestaciones

Marith Ubilda Guevara Idrogo
Gerenta Adjunta

Equipo técnico:

- Albarracín Celis, Roberto Carlos (MC.)
- Aliaga Sihuas, Lizet (CD.)
- Bocanegra Campos, Rosa María (MC.)
- Charca Quispe, Esteban Alberto (CD.)
- Quevedo Mar, Alex Francisco (MC.)
- Quispe Huamán, Patricia Gladys (MC.)
- Sifuentes Mendoza, Raúl Hugo (Ing.)
- Anco Pola, Dulio Manuel (MC.)
- Castro Dañobeytia, Verónica Eveling (Lic. Enf.)
- Cuéllar Durán, Karina (MC.)
- Fernández Salcedo, Creazy María (MC.)
- Figueroa Maturrano, Sherly Katherine (Lic. Enf.)
- Peralta Cárdenas, Miguel Ángel (CD.)

Colaboradores:

- Anccori Chalco, Jenny Jessica (Bach. Ing.)
- Cruz Bejarano, Segundo Rogelio (MC.)
- García Celestino, Jessica Rossana (QF.)
- Javier Bartolo, Cintia Nataly (MC.)
- Nazario Arancibia, Juan Carlos (MC.)
- Ortiz Castiglioni, Yesica Milagros (MC.)
- Palma Meneses, Juan Carlos (Lic. Enf.)
- Santos Angulo, Jefferson G. (Ing.)

Agradecimiento

Al Equipo Nacional de Auditores de Seguros del SIS, cuyo compromiso técnico, experiencia especializada y aportes sustantivos resultaron fundamentales en la elaboración, revisión y validación del documento “Criterios Técnicos para el Registro Modular por Curso de Vida en el Formato Único de Atención”.

1 INTRODUCCIÓN 4
2 FINALIDAD 5
3 OBJETIVOS 5
3.1 Objetivo General 5
3.2 Objetivo Específico 5
4 ÁMBITO DE APLICACIÓN 5
5 BASE LEGAL 5
6 CONTENIDO 7
6.1 Registro de los códigos prestacionales en el primer nivel de atención 7
6.1.1 Identificación del problema (con línea base 2019–2025) 7
6.1.2 Hallazgos Estratégicos 10
6.2 Modelo de Cuidado Integral por Curso de Vida 10
6.2.1 Definición 10
6.2.2 Periodos del curso de vida 11
6.3 Implementación de los códigos modulares por curso de vida 11
6.3.1 Creación de los códigos modulares por curso de vida 11
6.3.2 Detalle por código prestacional por curso de vida 12
6.3.3 Fortalecimiento del marco de control prestacional mediante la actualización e incorporación de Reglas de Consistencia para los códigos por curso de vida. 14
6.4 Disposiciones Técnicas para el Registro de los Códigos por Curso de Vida 17
6.4.1 Invariabilidad de la Estructura del Formato Único de Atención (FUA) 17
6.4.2 Lineamientos para el Registro del Código por Curso de Vida en el FUA 17
6.4.3 Registro Complementario en el Reverso del FUA 17
6.4.4 Responsabilidad Profesional: Firma y Sello en el Anverso del FUA 18
6.4.5 Régimen de Coexistencia y Uso Concurrente de Códigos Prestacionales 18
7 ANEXOS 20
7.1 Definiciones operacionales de los códigos modulares por curso de vida 20
7.2 Compendio de Códigos Prestacionales y definiciones operativas 22

1 INTRODUCCIÓN

El registro prestacional constituye un proceso crítico del aseguramiento público, en tanto sustenta la trazabilidad de la atención, la calidad del dato y la auditoría. En el Seguro Integral de Salud (SIS), el Formato Único de Atención (FUA) es el instrumento oficial para la validación y el control de las prestaciones, conforme a la Directiva vigente.

Sin embargo, al analizar las prestaciones preventivas del primer nivel de atención se identifica una oportunidad de mejora operativa vinculada al esquema actual de codificación: la segmentación de actividades obliga, en una misma consulta, a generar FUAs adicionales por cada actividad registrada. Estos no constituyen atenciones distintas, sino registros adicionales que el profesional debe completar dentro de la misma atención, lo que incrementa la carga administrativa, genera distracción respecto del paciente y reduce la eficiencia del tiempo clínico.

Para dimensionar el fenómeno, se analizaron las atenciones preventivas del primer nivel con más de una actividad registrada durante el periodo 2019–2025. En este universo se identificó que:

- Se generaron 78,653,895 FUAs en atenciones con más de una actividad.
- De estos, 45,154,234 correspondieron a FUAs adicionales (registros derivados de la segmentación de actividades).
- Operativamente, el 57.4% de los registros en este grupo corresponde a FUAs adicionales, es decir, más de la mitad del esfuerzo de registro en este universo responde a fragmentación administrativa potencialmente evitable.

Este comportamiento se ha mantenido estable entre 2019 y 2025, con proporciones anuales de FUAs adicionales alrededor de 57%–58%, lo que evidencia un patrón estructural del proceso de registro. Asimismo, el 99.4% de estos FUAs adicionales se concentra en cinco perfiles profesionales Enfermería, Obstetricia, Odontología, Técnico en Enfermería y Medicina, lo que confirma que el fenómeno se encuentra principalmente asociado a actividades preventivas ejecutadas en el primer nivel.

En este contexto, el presente Documento Técnico propone lineamientos para la utilización de códigos modulares por curso de vida (301–306), orientados a consolidar en un solo FUA el registro de atenciones integrales realizadas en una misma atención. Esta medida busca reducir la fragmentación del registro, optimizar el tiempo clínico, disminuir la carga administrativa y fortalecer la consistencia y calidad de la información prestacional, sin afectar los mecanismos de control ni la trazabilidad del financiamiento.

2 FINALIDAD

Contribuir a la optimización del registro prestacional en el Formato Único de Atención (FUA) del primer nivel de atención, promoviendo la consolidación de las atenciones Integrales por curso de vida en un único registro por atención, mediante la incorporación de los códigos 301–306, en relación con el Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida, fortaleciendo la eficiencia operativa, la calidad del dato y la trazabilidad del financiamiento.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Establecer las disposiciones técnicas y operativas para la incorporación y uso estandarizado de los códigos modulares por curso de vida (301–306) en el registro prestacional del Formato Único de Atención (FUA) en el primer nivel de atención, definiendo criterios de aplicación y control orientados a reducir la generación de FUAs adicionales derivados de la segmentación de actividades y a fortalecer la calidad, consistencia y trazabilidad de la información prestacional.

3.2 Objetivo Específico

a) Precisar las definiciones técnicas y los criterios de aplicación para el uso de los códigos 301–306, estableciendo los supuestos de utilización, su articulación con otros códigos prestacionales vigentes y los escenarios en los que corresponde su registro.

b) Formalizar e implementar las Reglas de Consistencia (RC) y los ajustes operativos en los sistemas de información correspondientes, a fin de garantizar el adecuado control prestacional de los códigos 301–306, asegurando la coherencia entre curso de vida, diagnósticos, procedimientos y demás componentes del FUA.

4 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Documento Técnico es de aplicación en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del primer nivel de atención dependientes de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA), Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) o las instancias que hagan sus veces, siempre que cuenten con convenio vigente suscrito con el Seguro Integral de Salud (SIS).

5 BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Decreto Supremo N° 023-2021-SA, que aprueba el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)

- Decreto Supremo N° 011-2011-SA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SIS.
- Decreto Legislativo N° 1163, que aprueba las Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud.
- Decreto Supremo N° 030-2014-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1163.
- Resolución Ministerial N° 827-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 105-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna".
- Resolución Ministerial N° 456-2016/MINSA, que aprueba el Documento Técnico, orientaciones para la Atención Integral de Salud en la etapa de vida joven.
- Resolución Ministerial N° 1001-2019/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud del Adolescente.
- Resolución Ministerial N° 030-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)".
- Resolución Ministerial N° 220-2021-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manual de Implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la persona, Familia y Comunidad (MCI).
- Resolución Ministerial N°789-2023-MINSA, que aprueba la NTS N° 207-MINSA/DGIESP-2023, Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores.
- Resolución Ministerial N° 545-2024-MINSA, que aprueba la NTS N° 214-MINSA/DGIESP-2024, Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal.
- Resolución Ministerial N°310-2025-MINSA, que aprueba la NTS N° 229-MINSA/DGIESP-2025, Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral de Salud de la Persona Adulta.
- Resolución Ministerial N° 682-2025-MINSA, que aprueba la NTS N° 238-MINSA/DGIESP-2025, Norma Técnica de salud para el crecimiento y desarrollo del niño.
- Resolución Ministerial N.° 709-2025-MINSA, que modifica la NTS N° 196-MINSA/DGIESP-2022 "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación", aprobada por Resolución Ministerial N° 884-2022/MINSA.
- Resolución Jefatural N° 000178-2024-SIS/J, que aprueba la Directiva N° 002-2024-SIS/GREP-V.02, “Directiva para el registro de la información de las prestaciones otorgadas a los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) en el Formato Único de Atención (FUA)” y sus anexos.
- Resolución Jefatural N° 000115-2025-SIS/J, aprueba la Directiva N° 001-2025-SIS/GREP-V.01, “Directiva que regula la auditoría de seguros de las prestaciones de salud brindadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que cuentan con convenio o contrato con el Seguro Integral de Salud (SIS)”.

6 CONTENIDO

6.1 Registro de los códigos prestacionales en el primer nivel de atención

6.1.1 Identificación del problema (con línea base 2019–2025)

El análisis técnico del registro prestacional efectuado en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, utilizando la base de datos correspondiente al periodo 2019–2025, evidenció un patrón recurrente de fragmentación en el registro de las atenciones. Se identificó que, para una misma atención brindada por un profesional de la salud a un paciente dentro de una única atención, se generaban múltiples Formatos Únicos de Atención (FUA).

Esta situación se explicaba por el diseño estructural de los códigos prestacionales vigentes, los cuales representaban actividades individuales o componentes específicos de la atención, sin integrar de manera consolidada el conjunto de intervenciones que conforman una atención integral. Como consecuencia, el registro tendía a disgregarse en varios FUAs para un mismo evento asistencial, afectando la eficiencia operativa, la consistencia del dato y la trazabilidad prestacional.

Listado de códigos prestacionales con diseño basado en actividades independientes, utilizados en el registro del primer nivel de atención.

001: Control de crecimiento y desarrollo en menores entre 0–4 años.
002: Control del recién nacido con menos de 2,500 gr, prematuro y con secuelas al nacer.
005: Consejería Nutricional para Niñas o Niños en Riesgo Nutricional y Desnutrición.
007: Suplemento de micronutrientes.
008: Profilaxis antiparasitaria.
009: Atención prenatal.
010: Atención de puerperio normal.
011: Exámenes de laboratorio completos de la gestante.
013: Exámenes de ecografía obstétrica.
015: Diagnóstico del embarazo.
016: Atención temprana para menores de 36 meses.
017: Atención Integral del Adolescente.
018: Salud reproductiva (planificación familiar).
019: Detección de trastorno de agudeza visual y ceguera.
020: Salud Bucal.
021: Prevención de caries.
022: Detección de problemas de salud mental.
023: Detección precoz de cáncer de próstata (PSA).
024: Detección precoz de cáncer cérvico-uterino.

025: Detección precoz de cáncer de mama (Mamografía).

029: Tamizaje Neonatal.

056: Consulta externa.

057: Restauración dental simple (Obturación y curación dental simple).

058: Restauración dental compuesta (Obturación y curación dental compuesta).

059: Extracción dental (exodoncia).

060: Atención extramural en zona urbana y urbana marginal (visita domiciliaria: recuperativo y/o preventivo).

061: Atención en tópico.

062: Atención por emergencia.

070: Atención odontológica especializada.

071: Apoyo al diagnóstico.

074: Tratamiento ITS en adolescentes, adultos y adultos mayores.

075: Atención extramural en zona rural (visita domiciliaria: recuperativo y/o preventivo).

118: Control de crecimiento y desarrollo en menores entre 5–9 años.

119: Control de crecimiento y desarrollo 10–11 años.

200: Atención de Rehabilitación.

900: Prótesis dental removible.

902: Atención Preconcepcional.

903: Atención Integral del Adulto Mayor.

904: Atención Integral del Joven y Adulto.

906: Consulta Externa por Profesional no médico ni odontólogo.

908: Atención Domiciliaria.

911: Instrucción de Higiene Oral y Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales.

En dicho contexto, la configuración operativa del registro prestacional establecía que cada actividad consignada durante la consulta debía documentarse mediante un Formato Único de Atención (FUA) independiente, aun cuando todas las intervenciones correspondieran a una misma atención y a una única atención.

Esta lógica de registro fragmentado generaba la emisión de dos o más FUAs por un mismo evento asistencial, produciendo duplicidad documental innecesaria, incremento de la carga administrativa para el personal asistencial y de admisión, mayor probabilidad de inconsistencias en la codificación y una reducción efectiva del tiempo destinado a la atención clínica directa.

Asimismo, cuando durante la consulta se identificaban intervenciones complementarias no previstas inicialmente —como tamizajes, consejerías o procedimientos preventivos— el usuario debía retornar al área de admisión para la emisión de nuevos FUAs, ampliando el circuito administrativo, generando tiempos adicionales de espera, afectando la

continuidad operativa del servicio e incrementando el riesgo de interrupción del proceso de atención.

Con el propósito de dimensionar objetivamente la magnitud del fenómeno, el análisis se circunscribió al universo de atenciones multiactividad, entendidas como aquellas en las que se registraron dos o más actividades dentro de una misma atención, utilizando la base de producción correspondiente al periodo 2019–2025.

En este universo específico se evidenció una proporción relevante de FUAs excedentes atribuible al uso de códigos prestacionales segmentados por actividad, confirmándose que la estructura de codificación vigente inducía a la generación de registros múltiples para una misma atención, incrementando artificialmente el volumen documental sin que ello reflejara necesariamente un mayor número de eventos asistenciales reales.

Esta situación no solo impactaba en la eficiencia operativa de los establecimientos de salud, sino también en la calidad y trazabilidad de la información prestacional utilizada para fines de control, auditoría y toma de decisiones. La sobreproducción documental generaba distorsiones en los indicadores de producción y complicaba la interpretación real de la carga asistencial. En consecuencia, se hacía necesaria una revisión estructural del esquema de codificación, orientada a promover un registro integral, coherente y alineado con el enfoque de cuidado por curso de vida.

Comportamiento anual (2019–2025):

Los porcentajes anuales de FUAs adicionales se mantuvieron consistentemente en un rango aproximado de 57% a 58% a lo largo del periodo analizado, lo que evidencia un comportamiento estructural y sostenido en el universo de atenciones multiactividad. Este nivel de estabilidad porcentual confirma que el fenómeno no responde a variaciones coyunturales, sino a un patrón recurrente asociado al diseño del registro prestacional vigente.



6.1.2 Hallazgos Estratégicos

a) Alta concentración en grupos asistenciales clave

El 99.37% de los FUAs adicionales se generan en cinco profesiones asistenciales: Enfermería, Obstetricia, Odontología, Técnico en Enfermería y Medicina.

Este comportamiento confirma que el fenómeno está directamente vinculado al modelo operativo del primer nivel de atención y al diseño fragmentado de los códigos prestacionales, impactando principalmente en las actividades clínicas de mayor volumen.

b) Carga administrativa estructural

La emisión acumulada de más de 45 millones de FUAs adicionales en siete años evidencia una presión operativa sostenida sobre el sistema, con efectos directos en:

- Incremento del tiempo destinado al registro por el personal asistencial.
- Sobrecarga en los módulos de admisión.
- Ampliación del circuito administrativo interno.
- Mayor exposición a inconsistencias y observaciones en auditoría.
- Afectación del flujo y oportunidad de la atención.

El impacto no es coyuntural, sino estructural y recurrente.

c) Afectación a la eficiencia clínica

La fragmentación del registro reduce el tiempo efectivo destinado a la atención directa, afecta la continuidad del cuidado y limita la capacidad del profesional para brindar una atención integral centrada en el paciente.

En términos sistémicos, el modelo actual prioriza el cumplimiento documental por encima de la eficiencia asistencial.

6.2 Modelo de Cuidado Integral por Curso de Vida

El Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida (MCI) constituye el marco conceptual y operativo que orienta la provisión de cuidados en salud con enfoque de atención primaria y perspectiva de curso de vida, y fue aprobado por el MINSA mediante Resolución Ministerial N.° 030-2020/MINSA. Asimismo, su despliegue operativo se fortalece con instrumentos de implementación, entre ellos el Manual de Implementación aprobado por RM N.° 220-2021/MINSA, referido en normativa institucional y documentos de gestión sanitaria.

6.2.1 Definición

El MCI se define como el conjunto articulado de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que, de manera complementaria, responden a las necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad. Integra los atributos de la Atención Primaria de Salud (APS) y enfatiza la construcción de un vínculo sostenido entre la población y los equipos multidisciplinarios de salud (EMS), para mejorar la salud durante

todo el curso de vida con base en información de necesidades por grupos etarios y la diversidad territorial del país.

6.2.2 Periodos del curso de vida

En coherencia con el MCI, el curso de vida se organiza en los siguientes periodos: prenatal, niña/niño (0 a 11 años, 11 meses y 29 días), adolescente (12 a 17 años, 11 meses y 29 días), adulto joven (18 a 29 años, 11 meses y 29 días), adulto (30 a 59 años, 11 meses y 29 días) y adulto mayor (60 a más).

6.3 Implementación de los códigos modulares por curso de vida

6.3.1 Creación de los códigos modulares por curso de vida

En el marco del análisis del registro prestacional correspondiente al periodo 2019–2025, se identificó que la estructura segmentada de los códigos vigentes generaba la emisión de múltiples FUAs para una misma atención multiactividad, configurando un volumen significativo de FUAs adicionales. Esta situación evidenció la necesidad de implementar un mecanismo técnico que permita consolidar, en un único código prestacional, el conjunto de intervenciones realizadas dentro de una misma atención, asegurando un registro integral, consistente y operativo.

En atención a ello, la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones (GREP), en concordancia con el Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad aprobado por el Ministerio de Salud, y alineada con la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 – Perú País Saludable, particularmente con el Objetivo Prioritario 2 orientado a asegurar el acceso a servicios integrales, oportunos y de calidad, dispuso la incorporación de seis (6) códigos modulares estructurados por curso de vida.

Estos códigos modulares comprenden, de manera articulada, intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, permitiendo registrar de forma consolidada las actividades realizadas en una atención multiactividad sin necesidad de generar múltiples FUAs por componentes individuales.

Asimismo, dichos códigos contemplan la trazabilidad del consumo de Productos Farmacéuticos (PF), Dispositivos Médicos (DM) y Productos Sanitarios (PS), así como el registro de Procedimientos Médicos y Sanitarios vinculados a diagnósticos CIE-10, garantizando coherencia clínica, consistencia documental y alineamiento con los instrumentos técnicos sectoriales vigentes.

La implementación de estos códigos contribuye directamente a:

- Reducir estructuralmente la generación de FUAs adicionales.
- Optimizar el tiempo destinado al registro de FUAs por parte del personal asistencial.
- Simplificar el circuito administrativo en los establecimientos del primer nivel.

- Disminuir el riesgo de inconsistencias y observaciones en auditoría.
- Fortalecer la calidad, oportunidad y continuidad de la atención integral centrada en la persona.

De este modo, la creación de los códigos por curso de vida constituye una medida correctiva estructural orientada a mejorar la eficiencia del sistema de registro prestacional sin afectar la trazabilidad técnica ni el control financiero de las prestaciones financiadas por el SIS.

Cuadro 1. Nuevos Códigos Prestacionales por curso de vida

Código de Prestación	Descripción
301	Cuidado Integral por curso de vida del Niño
302	Cuidado Integral por curso de vida del Adolescente
303	Cuidado Integral de la salud por curso de vida del Joven
304	Cuidado Integral de la salud por curso de vida Adulto
305	Cuidado Integral de la salud por curso de vida Adulto Mayor
306	Cuidado Integral de la salud Prenatal

6.3.2 Detalle por código prestacional por curso de vida

Código Prestacional para el Cuidado Integral del Niño

- Código prestacional
  301
- Curso de Vida Aplicable
  Atiende a la población desde el recién nacido hasta los 11 años, 11 meses y 29 días.
- Actividades Incluidas en el Código Prestacional
  El código 301 comprende las intervenciones preventivas, promocionales, recuperativas, de rehabilitación y paliativas que se realizan durante una atención de salud del niño.
- Control prestacional
  Para el registro y validación del código 301 se aplican las reglas de control de registro y las reglas de consistencia, garantizando que todas las intervenciones correspondan al curso de vida.

Código Prestacional para el Cuidado Integral del adolescente

- Código prestacional
  302
- Curso de Vida Aplicable
  Atiende a la población desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días.
- Actividades Incluidas en el Código Prestacional
  El código 302 comprende las intervenciones preventivas, promocionales, recuperativas, de rehabilitación y paliativas realizadas durante una atención de salud del adolescente.
- Control prestacional
  Para el registro y validación del código 302 se aplican las reglas de control de registro y las reglas de consistencia, garantizando que todas las intervenciones correspondan al curso de vida del adolescente.

Código Prestacional para el Cuidado Integral del joven

- Código prestacional
  303
- Curso de Vida Aplicable
  Atiende a la población desde los 18 años hasta los 29 años, 11 meses y 29 días.
- Actividades Incluidas en el Código Prestacional
  El código 303 comprende las intervenciones preventivas, promocionales, recuperativas, de rehabilitación y paliativas realizadas durante una atención de salud del joven.
- Control prestacional
  Para el registro y validación del código 303 se aplican las reglas de control de registro y de consistencia, garantizando su correspondencia con el curso de vida del joven.

Código Prestacional para el Cuidado Integral del adulto

- Código prestacional
  304
- Curso de Vida Aplicable
  Atiende a la población desde los 30 años hasta los 59 años, 11 meses y 29 días.
- Actividades Incluidas en el Código Prestacional
  El código 304 comprende las intervenciones preventivas, promocionales, recuperativas, de rehabilitación y paliativas realizadas durante una atención de salud del adulto.
- Control prestacional
  Para el registro y validación del código 304 se aplican las reglas de control de registro y las reglas de consistencia, asegurando que las intervenciones correspondan al curso de vida del adulto.

Código Prestacional para el Cuidado Integral del adulto mayor

- Código prestacional
  305
- Curso de Vida Aplicable
  Atiende a la población de 60 años a más.
- Actividades Incluidas en el Código Prestacional
  El código 305 comprende las intervenciones preventivas, promocionales, recuperativas, de rehabilitación y paliativas realizadas durante una atención de salud del adulto mayor.
- Control prestacional
  Para el registro y validación del código 305 se aplican las reglas de control de registro y las reglas de consistencia, garantizando que todas las intervenciones correspondan al curso de vida del adulto mayor.

Código Prestacional para el Cuidado Integral de la salud Prenatal

- Código prestacional
  306
- Curso de Vida Aplicable
  Orientado a la gestante.
- Actividades Incluidas en el Código Prestacional
  El código 306 comprende las intervenciones preventivas, promocionales, recuperativas, de rehabilitación realizadas durante una atención de salud de la gestante (durante el embarazo, parto y puerperio).
- Control prestacional
  Para el registro y validación del código 306 se aplican las reglas de control de registro y las reglas de consistencia, garantizando que todas las intervenciones correspondan a la mujer gestante.

6.3.3 Fortalecimiento del marco de control prestacional mediante la actualización e incorporación de Reglas de Consistencia para los códigos por curso de vida.

La incorporación de los códigos modulares por curso de vida (301, 302, 303, 304, 305 y 306), diseñados como mecanismos integradores para el registro de atenciones multiactividad, requirió la adecuación del sistema de control prestacional a través de la actualización y creación de Reglas de Consistencia (RC).

Estas reglas constituyen parámetros técnicos automatizados orientados a garantizar la calidad, coherencia clínica y validez administrativa del registro en el Formato Único de Atención (FUA), asegurando que la consolidación de intervenciones en un solo código no afecte la trazabilidad ni el control financiero de las prestaciones.

En tal sentido, las Reglas de Consistencia implementadas permiten:

- Verificar la correspondencia entre el código por curso de vida y el grupo etario del asegurado.
- Validar la congruencia entre diagnósticos CIE-10 registrados y los procedimientos médicos sanitarios asociados.
- Controlar el correcto registro del consumo de Productos Farmacéuticos (PF), Dispositivos Médicos (DM) y Productos Sanitarios (PS).
- Evitar incompatibilidades con otros códigos prestacionales que no resulten procedentes en la misma atención.
- Detectar inconsistencias que puedan generar observaciones posteriores en auditoría.

La actualización de las reglas no solo mantiene el estándar de control técnico previamente existente, sino que lo fortalece, permitiendo que el nuevo esquema integrador reduzca la generación de FUAs excedentes sin debilitar los mecanismos de supervisión, control y sostenibilidad financiera del aseguramiento público.

De esta manera, la implementación de las Reglas de Consistencia asociadas a los códigos por curso de vida constituye un componente esencial del rediseño del registro prestacional, asegurando equilibrio entre simplificación operativa y rigor técnico.

6.3.3.1 Actualización de Reglas de Consistencia Existentes

- **RC01 – Consistencia de registro de prestaciones por edad, sexo y condiciones del asegurado**

  Se actualizó la regla incorporando los códigos 301, 302, 303, 304, 305 y 306, y se actualizó la ficha técnica correspondiente.

- **RC04 – Criterios de registro del destino del asegurado por prestación**

  Se agregaron los códigos 301, 302, 303, 304, 305 y 306 y se actualizó la ficha técnica.

- **RC12 – Registro obligatorio de medicamentos, insumos y/o procedimientos asociados a la prestación.**

  Se incluyeron los códigos 301 al 306, estableciendo que no podrá registrarse la prestación si se omite el registro de medicamentos o insumos o procedimientos correspondientes.

- **RC14 – Obligatoriedad de registro de actividades preventivas y clínicas por código prestacional**

  Se añadió el Cuadro N.º 7, el cual aplica la regla según la relación entre código de servicio y diagnóstico registrado.

- **RC20 – Consistencia de registro de procedimientos según perfil profesional y nivel de atención**

  Se incluyeron los códigos 301 y 306.

  Se adicionaron CPMS según tipo de profesional.

- **RC30 – Registro obligatorio de fecha probable de parto/fecha de parto en prestaciones obstétricas**

  Se incorporó el código 306.

- **RC31 – Registro obligatorio de resultados en procedimientos clínicos**

  Se añadieron los códigos 301, 302, 303, 304, 305 y 306.

- **RC32 – Consistencia clínica en procedimientos mutuamente excluyentes.**

  Se incluyó el código 306 en las reglas de Parto Vaginal.

- **RC33 – Registro obligatorio de datos del recién nacido**

  Se incorporaron CIE-10 asociados al parto.

- **RC34 – Registro de diagnóstico obligatorio en tamizaje de salud mental patológico**

  Se añadieron los códigos 301, 302, 303, 304, 305 y 306.

- **RC35 – Registro de medicamentos específicos por código prestacional o diagnostico**

  Se incorporaron CIE-10 relacionados a SISMED, fortaleciendo la relación entre diagnóstico y tratamiento.

- **RC39 – Límites de registro por procedimiento, vinculados a códigos prestacionales**

  Se incluyeron los códigos 301 al 306.

- **RC42 – Registro de atenciones posteriores a la fecha de fallecimiento**

  Se incorporaron los códigos 301 al 306 para evitar registros posteriores a la fecha consignada de fallecimiento.

- **RC47 – Consistencia multinivel y multivariables en procedimientos**

  Se incorporaron los códigos 301, 302, 303 y 304, considerando su aplicabilidad por curso de vida.

- **RC86 – Consistencia avanzada para la prevención de duplicidades III**

  Se añadieron los códigos 301 al 306 en el control de duplicidad intradía.

6.3.3.2 Creación e Implementación de Nuevas Reglas de Consistencia

- **RC88 – Consistencia entre los diagnósticos y procedimientos según curso de vida**

  Se inactivó la Regla de Validación N.º 19 y se implementó como Regla de Consistencia inmediata, aplicable a los códigos por curso de vida.

- **RC89 – Registro condicionado de procedimientos a diagnósticos según curso de vida**

  Se implementó la Regla de Consistencia N.º 89 como regla inmediata para los códigos 301, 302, 303, 304, 305 y 306, definiendo los límites operativos de procedimientos por atención.

- **RC92 – Consistencia de registro de códigos prestacionales por nivel de atención**

  Se incorporó los códigos 301, 302, 303, 304, 305 y 306 para permitir el registro en el primer nivel de atención.

6.4 Disposiciones Técnicas para el Registro de los Códigos por Curso de Vida

6.4.1 Invariabilidad de la Estructura del Formato Único de Atención (FUA)

La implementación de los Códigos modulares por Curso de Vida (301 al 306) no implica modificación alguna en la estructura, campos ni diseño del Formato Único de Atención (FUA).

El FUA mantiene su configuración oficial conforme al **Anexo N.º 01 de la Directiva N.º 002-2024-SIS/GREP-V.02**, "Directiva para el registro de la información de las prestaciones otorgadas a los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) en el Formato Único de Atención (FUA)", aprobada mediante Resolución Jefatural N.º 000178-2024-SIS/J.

En consecuencia, la incorporación de los nuevos códigos se realiza dentro del marco normativo vigente, sin generar cambios estructurales ni requerimientos adicionales en el instrumento de registro.

6.4.2 Lineamientos para el Registro del Código por Curso de Vida en el FUA

Los Códigos por Curso de Vida (301 al 306) deberán registrarse en la sección **"De la Atención"**, específicamente en el campo **Código de Prestación (COD. PRESTA.)**, conforme a lo establecido en la el ítem 1.4 literal c) del Anexo N.º 03 – *Criterios para el Registro de Prestaciones de Salud en el FUA*, de la Directiva N.° 002-2024-SIS/GREP-V.02.

Este registro identifica la atención integral realizada bajo el enfoque de curso de vida, consolidando en un solo código las intervenciones efectuadas dentro de la misma atención.

La consignación correcta del código constituye un elemento clave para la consistencia del registro prestacional, la trazabilidad del financiamiento y el adecuado control posterior.

6.4.3 Registro Complementario en el Reverso del FUA

En el reverso del FUA se continuará consignando, sin variación normativa, la información correspondiente a:

- Productos farmacéuticos
- Dispositivos médicos
- Productos sanitarios
- Procedimientos
- Actividades de apoyo al diagnóstico

La codificación aplicable se mantiene conforme a los catálogos y manuales vigentes.

Para el diseño técnico de los Códigos por Curso de Vida se tomó como referencia la codificación CPMS establecida en los Manuales de Registro y Codificación de Actividades del Sistema de Información HIS del Ministerio de Salud, garantizando:

- Coherencia técnica entre sistemas de información
- Homologación de criterios de registro
- Interoperabilidad conceptual
- Integridad del dato asistencial

De esta manera, el nuevo esquema no altera la lógica del registro complementario, sino que fortalece su integración bajo un enfoque integral.

6.4.4 Responsabilidad Profesional: Firma y Sello en el Anverso del FUA

El registro de los Códigos por Curso de Vida (301 al 306) se efectúa por cada atención de salud individual, aplicando el mismo principio de unicidad de atención establecido para los códigos prestacionales previamente vigentes.

En consecuencia:

- Cada FUA corresponde a una sola atención.
- Cada FUA debe ser firmado y sellado por el responsable de la atención.
- El personal de salud que firma asume responsabilidad técnica, legal y administrativa sobre la veracidad y consistencia del registro.

Se precisa que la incorporación de estos códigos no habilita la elaboración de un FUA compartido entre múltiples profesionales.

Cuando intervengan distintos profesionales en atenciones independientes, deberá generarse el FUA correspondiente por cada atención efectivamente realizada.

Esta disposición garantiza claridad en la atribución de responsabilidades y seguridad jurídica en el proceso de control prestacional.

6.4.5 Régimen de Coexistencia y Uso Concurrente de Códigos Prestacionales

La incorporación de los Códigos modulares por Curso de Vida no deroga, sustituye ni limita la vigencia de los códigos prestacionales previamente existentes.

Todos los códigos mantienen plena validez normativa y pueden emplearse de manera concurrente, siempre que:

- Sean coherentes con la naturaleza de la atención brindada.
- Se ajusten a los criterios técnicos establecidos en las reglas de consistencia vigentes.
- Respondan al tipo de intervención efectivamente realizada.
- Se encuentren dentro del marco operativo definido por la IPRESS y el financiamiento correspondiente.

Todos los códigos prestacionales conservan plena vigencia normativa y pueden utilizarse de manera concurrente conforme a la naturaleza de la intervención realizada; sin embargo, ello no autoriza el registro duplicado de una misma atención.

Cuando una prestación de salud sea consignada mediante un Código Prestacional por Curso de Vida (301–306), queda excluida la posibilidad de registrar simultáneamente esas mismas actividades mediante códigos fragmentados en otros FUA.

No es procedente generar un FUA adicional por el mismo evento asistencial bajo distinta codificación. Cada atención debe registrarse una única vez, utilizando el código que refleje con mayor precisión su integralidad y pertinencia técnica, a fin de preservar la consistencia del dato, evitar sobreestimaciones de producción y garantizar la transparencia del financiamiento y del control prestacional.

Cuando una prestación de salud sea consignada mediante un Código Prestacional por curso de vida, queda excluida la posibilidad de registrar simultáneamente esas mismas atenciones mediante códigos fragmentados en otros FUA.

7 ANEXOS

7.1 Definiciones operacionales de los códigos modulares por curso de vida

Código prestacional	Denominación	Definición operacional
301	Cuidado Integral por curso de vida del Niño	**Código: 301** Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral en el niño y niña; a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, orientadas al bienestar físico y mental, el desarrollo cognitivo, psicomotor, emocional, afectivo y social, así como, reducir la morbilidad y mortalidad infantil. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención Aplica para el Curso de Vida: 0 a 11 años 11 meses y 29 días.
302	Cuidado Integral por curso de vida del Adolescente	**Código:302** Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral del adolescente; a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, dirigidas al desarrollo físico, maduración mental, desarrollo intelectual, desarrollo emocional y desarrollo social. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Aplica para el Curso de Vida: 12 a 17 años 11 meses y 29 días.
303	Cuidado Integral de la salud por curso de vida del Joven	**Código:303** Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral del joven; a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, identificando precozmente los factores y conductas de riesgo, así como los problemas de salud; orientadas al desarrollo físico, maduración mental, desarrollo intelectual, desarrollo emocional y desarrollo social. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Aplica para el Curso de Vida: 18 a 29 años, 11 meses y 29 días.

Código prestacional	Denominación	Definición operacional
304	Cuidado Integral de la salud por curso de vida Adulto	**Código:304** Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral en el adulto; a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, dirigidas para satisfacer las necesidades de salud que fomenten las conductas de autocuidado, prevención y promoción de comportamientos saludables. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Aplica para el Curso de Vida: 30 a 59 años 11 meses 29 días.
305	Cuidado Integral de la salud por curso de vida Adulto Mayor	**Código:305** Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral en el adulto mayor, a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños a la salud, diagnóstico, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos y seguimiento, prestados por el personal de salud, dirigidas para satisfacer las necesidades de salud, reduciendo los periodos de enfermedad y promoviendo su autonomía e independencia. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Aplica para el Curso de Vida: 60 años a más.
306	Cuidado Integral de la salud Prenatal	**Código:306** Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral de la gestante (durante el embarazo, parto y puerperio), a través de intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, orientadas a lograr el bienestar físico y mental, emocional, afectivo y social, así como, reducir la morbilidad y mortalidad. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Aplica para el Curso de Vida: Mujer gestante

7.2 Compendio de Códigos Prestacionales y definiciones operativas

El Compendio de Códigos Prestacionales surge como una herramienta técnica orientada a fortalecer el control prestacional y mejorar la calidad del registro de las atenciones de salud. Los códigos prestacionales cumplen una función estratégica dentro del sistema de información, ya que se encuentran directamente vinculados a la lógica de las reglas de auditoría automatizada, permitiendo ejecutar controles de registro, consistencia y validación. En este marco, actúan como marcadores estructurados que identifican el tipo de prestación consignada y activan los algoritmos de verificación correspondientes, contribuyendo a garantizar la integridad, coherencia y trazabilidad de la información.

Es importante precisar que los códigos prestacionales tienen naturaleza estrictamente registral y de uso operativo en el Formato Único de Atención (FUA), no constituyen prestaciones valorizadas ni generan reconocimiento económico, ya que su finalidad es exclusivamente técnica y de control. Su adecuada utilización impacta directamente en la calidad del dato, en la eficiencia de los procesos de validación automatizada y en la transparencia del sistema de registro prestacional.

Considerando la relevancia de estos códigos y la necesidad de contar con definiciones operacionales claras, uniformes y alineadas con la normativa vigente, se elaboró el Compendio de Códigos Prestacionales como un instrumento técnico–normativo que consolida, sistematiza y estandariza los criterios de aplicación. Este documento incorpora las actualizaciones pertinentes derivadas de la normativa emitida por la Autoridad Nacional de Salud, asegurando coherencia regulatoria y adecuada interpretación operativa.

El compendio establece para cada código su denominación, definición operacional, criterios de registro, restricciones y, cuando corresponde, la base normativa que lo sustenta. De esta manera, se reduce la discrecionalidad en su uso, se minimizan ambigüedades y se fortalecen los mecanismos de control automatizado. Asimismo, se configura como un documento de referencia institucional para todos los responsables del registro prestacional.

En consecuencia, el Compendio de Códigos Prestacionales constituye una herramienta estratégica para la estandarización del registro, el fortalecimiento del control prestacional y la mejora continua de la gestión sanitaria, contribuyendo a garantizar mayor consistencia, transparencia y calidad en la información registrada.

Código	Descripción, población objetivo, base legal.
001	**Control de crecimiento y desarrollo en menores de 0–4 años.**
	Definición operacional Conjunto de actividades periódicas y secuenciales realizado por el licenciado en enfermería o médico cirujano, con el objetivo de vigilar el crecimiento y desarrollo, detectar riesgos y alteraciones de forma oportuna, e implementar intervenciones para el cuidado integral del niño. El control de CRED comprende cuatro procesos secuenciales: Valoración, diagnóstico, intervención y seguimiento, a fin de mejorar las prácticas de cuidado, alimentación y crianza de la familia. Población objetivo (rango etario) De 0 a 4 años, 11 meses y 29 días. Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** R.M. N.° 682-2025-MINSA.
002	**Control del recién nacido con menos de 2,500 gr, prematuro y con secuelas al nacer.**
	Definición operacional Conjunto de actividades periódicas y secuenciales realizado por el licenciado en enfermería o médico cirujano, con el objetivo de vigilar el crecimiento y desarrollo, detectar riesgos y alteraciones de forma oportuna, e implementar intervenciones para el cuidado integral del niño. El control de CRED comprende cuatro procesos secuenciales: Valoración, diagnóstico, intervención y seguimiento, a fin de mejorar las prácticas de cuidado, alimentación y crianza de la familia. Población objetivo (rango etario) De 0 a 28 días de nacido Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 545-2024-MINSA

005	**Consejería Nutricional para Niñas o Niños en Riesgo Nutricional y Desnutrición.**
	Definición operacional Es un proceso educativo y comunicacional, concebido como un dialogo participativo, que facilita a la madre, padre o cuidador principal la comprensión de los factores que influyen en la salud, nutrición y desarrollo del niño, identificando durante la valoración. Permite la identificación conjunta de alternativas y la toma de decisión, basadas en los resultados de la evaluación nutricional y en el análisis de las prácticas, fortaleciendo aquellas que se identifican como positivas y corrigiendo las de riesgo, para asegurar un adecuado estado nutricional. Población objetivo (rango etario) 0 a 11 años, 11 meses y 29 días Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 034-2024-MINSA
007	**Suplemento de micronutrientes.**
	Definición operacional Esta intervención preventiva, tiene por objetico mantener los niveles adecuados de hierro en el organismo de los niños con suplemento de hierro y/o en combinación con otras vitaminas y minerales. Población objetivo (rango etario) 0 a 11 años, 11 meses y 29 días Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 251-2024-MINSA, RM N.° 429-2024-MINSA
008	**Profilaxis antiparasitaria.**
	Definición operacional Se refiere a la administración preventiva de medicamentos antihelminticos a intervalos regulares (02 veces al año) como profilaxis para prevenir el desarrollo de parasitosis intestinal debido a geohelmintos. Población objetivo (rango etario) Todas las personas mayores de 2 años de edad. Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 479-2017-MINSA

009	**Atención prenatal.**
	Definición operacional Comprende la atención preventiva de la gestante. Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, idealmente iniciado antes de las catorce semanas de gestación, para brindar un paquete básico de intervenciones que permita la detección oportuna de signos de alarma, factores de riesgo, la educación para el autocuidado y la participación de la familia, así como el manejo adecuado de las complicaciones; con enfoque de género e interculturalidad en el marco de los derechos humanos. Población objetivo (rango etario) Mujer gestante Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 827-2013-MINSA
010	**Atención de puerperio normal.**
	Definición operacional Conjunto sistematizado de actividades, intervenciones y procedimientos ambulatorios que se brinda a la mujer durante el periodo puerperal, con la finalidad de prevenir o detectar complicaciones. Población objetivo (rango etario) Mujeres dentro de los 42 días post parto Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 827-2013-MINSA
011	**Exámenes de laboratorio completo de la gestante.**
	Definición operacional Consiste en los exámenes de laboratorio que se deben solicitar a la gestante en la primera consulta, los cuales podrán ser realizados en el mismo EESS o en otro, de acuerdo a la capacidad resolutiva. Considera el set completo de exámenes de laboratorio: Hemoglobina, Glicemia, Grupo sanguíneo y Factor RH, Orina completa y urocultivo (o tira reactiva para bacteriuria en el primer nivel de atención), Serología (RPR o VDRL), Prueba de VIH (sea prueba de ELISA o prueba rápida), y otras de acuerdo a normatividad vigente. Población objetivo (rango etario) Mujer gestante Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 827-2013-MINSA

013	Exámenes de ecografía obstétrica.
	Definición operacional Procedimiento de apoyo al diagnóstico que permite evaluar el desarrollo del feto e inspeccionar los órganos pélvicos de la mujer durante el embarazo. Comprende los materiales e insumos utilizados del procedimiento de ayuda diagnóstica, que se emplea de forma rutinaria en todas las gestantes. Población objetivo (rango etario) Mujer gestante Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 827-2013-MINSA
015	**Diagnóstico del embarazo.**
	Definición operacional Se refiere al procedimiento de apoyo al diagnóstico que se realiza para el dosaje de la fracción beta de la GCH para diagnóstico de embarazo en toda mujer en edad fértil con sospecha de embarazo. Población objetivo (rango etario) Mujer en edad fértil Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 827-2013-MINSA
016	**Atención Temprana del Desarrollo menores de 36 meses.**
	Definición operacional La Atención Temprana del Desarrollo (ATD) es una intervención sanitaria integral, operativa y vivencial, ejecutada mediante sesiones grupales de 60 minutos. Su propósito es fortalecer las capacidades de los padres o cuidadores para optimizar el neurodesarrollo de la niña o niño menor de 36 meses. Se basa en el juego guiado, la observación y la promoción de un entorno de movimiento libre con seguridad afectiva y física. Población objetivo (rango etario) Menores de 36 meses Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 682-2025-MINSA

017	**Atención Integral del Adolescente.**
	Definición operacional La atención integral de salud comprende la provisión continua, integrada y con calidad de una atención orientada hacia la promoción, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación de la salud de las y los adolescentes, en el contexto de su vida en familia, institución educativa y en la comunidad. Población objetivo (rango etario) De 12 a 17 años 11 meses y 29 días. Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 1001-2019/MINSA
018	**Salud reproductiva (planificación familiar).**
	Definición operacional Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a mujeres y hombre en edad fértil, dentro de las cuales se encuentra la información, educación, orientación/consejería y la prescripción y provisión de métodos anticonceptivos, para que las personas o parejas ejerzan el derecho a decidir libre y responsablemente, si quieren o no tener hijos, así como el número y el espaciamiento entre ellos. Población objetivo (rango etario) Mujer en edad fértil Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 652-2016-MINSA
019	**Detección de trastorno de agudeza visual y ceguera.**
	Definición operacional Consiste en la detección precoz de trastornos de agudeza visual y ceguera en todas las etapas de vida. No incluye la provisión de lentes. Esta prestación consiste en la evaluación de la visión, medición de la agudeza visual y otros procedimientos que se establezcan en la normativa vigente. Población objetivo (rango etario) Todas las Edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** R.M. N.° 1009-2018/MINSA

020	**Salud bucal.**
	Definición operacional Se refiere a la atención estomatológica brindada por el Cirujano Dentista, que realiza el procedimiento de Evaluación oral completa. Población objetivo (rango etario) Todas las Edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 859-2024/MINSA
021	**Prevención de caries.**
	Definición operacional Se refiere a la atención estomatológica preventiva brindada por cirujano dentista, que realiza los procedimientos de Profilaxis Dental, Aplicación de Flúor Barniz, Aplicación de Flúor Gel, Aplicación de Sellantes. Población objetivo (rango etario) 6 meses a mas Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 1231-2021-MINSA
022	**Detección de problemas de salud mental.**
	Definición operacional Conjunto de actividades y procedimientos, orientados a la identificación precoz de problemas de salud mental, problemas psicosociales, trastornos mentales, violencia, así mismo la promoción del bienestar. Comprende la aplicación de fichas de tamizaje en Salud Mental y la Consejería en Salud Mental, ejecutados de acuerdo a normatividad vigente. Los temas priorizados son depresión, ansiedad, abuso de alcohol, psicosis/esquizofrenia y población víctima de violencia política. Población objetivo (rango etario) Todas las Edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 574-2017/MINSA, RM N° 670-2021/MINSA

023	**Detección precoz de cáncer de próstata.**
	Definición operacional Conjunto de actividades y procedimientos orientados a la detección precoz del cáncer de próstata mediante la realización del examen Antígeno Prostático Específico (PSA) y Examen digito rectal, de acuerdo a normatividad vigente. Comprende el procedimiento y la entrega del resultado acorde a normas vigente. Población objetivo (rango etario) Hombres de 50 a 75 años Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM. N.° 876-2024/MINSA, Guia Técnica N° 005-INS/CETS-2025. Vs.01
024	**Detección precoz de cáncer cérvico-uterino.**
	Definición operacional Conjunto de actividades y procedimientos (examen de Papanicolaou-PAP o examen citológico, Inspección visual con ácido acético-IVAA y otros que se determinen por norma), brindados según las normas técnicas vigentes. Se encuentran orientados a la detección precoz del cáncer cérvico-uterino en la etapa de vida Adolescente, Joven y Adulto. Población objetivo (rango etario) Mujeres de 25 a 65 años Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM. N.º 876-2024, RM N.° 480-2025-MINSA
025	**Detección precoz de cáncer de mama.**
	Definición operacional Conjunto de actividades y procedimientos (Evaluación anual del alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, examen clínico de mamas y la mamografía), orientados a la detección precoz del cáncer de mama, en la etapa de vida adulto y adulto mayor. Población objetivo (rango etario) Mujeres de 40 a 69 años Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM. N.° 876-2024/MINSA, RM. N° 725-2025/MINSA

026	**Tratamiento profiláctico a gestante positiva a la prueba rápida / ELISA VIH.**
	Definición operacional Se refiere al uso de antirretrovirales (ARV) en la gestante con infección por VIH, probable o confirmada. Se realiza en todos los establecimientos de salud del país, según su categoría, nivel de complejidad y de acuerdo a norma técnica vigente para la prevención de la transmisión vertical del VIH. El tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) de la gestante con infección por VIH, probable o confirmada deberá ser realizada por el Médico Infectólogo o médico capacitado según nivel de complejidad. Población objetivo (rango etario) Mujer gestante Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM. N° 1138-2019/MINSA.
027	**Tratamiento profiláctico a niños expuestos al VIH.**
	Definición operacional Prestación que se brinda para disminuir la transmisión madre - niño del VIH, comprende el uso de antirretrovirales en la recién nacida o nacido expuesto y la provisión de sucedáneos de leche materna, de acuerdo a los criterios establecidos por la norma técnica vigente. Población objetivo (rango etario) Menores de 12 meses Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 1138-2019/MINSA
029	**Tamizaje Neonatal.**
	Definición operacional Aplicación de procedimientos y pruebas a todos los recién nacidos con el objeto de identificar oportunamente a aquellos que puedan presentar alguna de las siguientes enfermedades: cuatro enfermedades metabólicas (hipotiroidismo congénito. hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y fibrosis quística), hipoacusia congénita, catarata congénita o patologías cardiacas críticas, con el propósito de prevenir discapacidad física y/o mental o la muerte prematura. Población objetivo (rango etario) Menores de 12 meses Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM. N.° 545-2024/MINSA, RM. N.° 558-2019/MINSA

118	**Control de crecimiento y desarrollo en menores entre 5 - 9 años.**
	Definición operacional Conjunto de actividades periódicas y secuenciales realizado por el licenciado en enfermería o médico cirujano, con el objetivo de vigilar el crecimiento y desarrollo, detectar riesgos y alteraciones de forma oportuna, e implementar intervenciones para el cuidado integral del niño. El control de CRED comprende cuatro procesos secuenciales: Valoración, diagnóstico, intervención y seguimiento, a fin de mejorar las prácticas de cuidado, alimentación y crianza de la familia. Población objetivo (rango etario) De 5 a 9 años, 11 meses y 29 días Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 682-2025-MINSA
119	**Control de crecimiento y desarrollo en menores entre 10 - 11 años.**
	Definición operacional Conjunto de actividades periódicas y secuenciales realizado por el licenciado en enfermería o médico cirujano, con el objetivo de vigilar el crecimiento y desarrollo, detectar riesgos y alteraciones de forma oportuna, e implementar intervenciones para el cuidado integral del niño. El control de CRED comprende cuatro procesos secuenciales: Valoración, diagnóstico, intervención y seguimiento, a fin de mejorar las prácticas de cuidado, alimentación y crianza de la familia. Población objetivo (rango etario) De 10 a 11 años, 11 meses y 29 dias Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 682-2025-MINSA
902	**Atención Preconcepcional.**
	Definición operacional Comprende el conjunto de actividades e intervenciones preventivas de atención integral dirigido a la mujer en edad fértil, a fin de promover los cuidados más adecuados durante el periodo preconcepcional y lograr un embarazo, parto y puerperio y un recién nacido en buen estado de bienestar biológico, psicológico y social. Población objetivo (rango etario) Mujeres en edad fértil Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° N° 827-2013/MINSA

903	**Atención Integral del Adulto Mayor.**
	Definición operacional Es una atención preventiva de atención integral al adulto mayor, que comprende un conjunto de prestaciones de salud contemplando las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud. Es individual, integral, oportuno, periódico y secuencial y requiere el diagnóstico de la evaluación nutricional. Población objetivo (rango etario) De 60 a más años Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° N°789-2023-MINSA
904	**Atención Integral del Joven y Adulto.**
	Definición operacional Es una atención preventiva de atención integral al joven y adulto, que comprende un conjunto de prestaciones de salud contemplando las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud. Es individual, integral, oportuno, periódico y secuencial y requiere el diagnóstico de la evaluación nutricional. Población objetivo (rango etario) De 18 - 59 años Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM. Nº 030-2020/MINSA
911	**Instrucción de Higiene Oral y Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales.**
	Definición operacional Intervención que comprende la enseñanza individual de la técnica de higiene oral según habilidad y desarrollo del usuario externo mediante el uso de cepillo, pasta fluorada e hilo dental; incluye también la detección de la placa bacteriana y la entrega de pasta dental fluorada y cepillo dental y el asesoramiento en la elección de alimentos y hábitos dietéticos saludables como parte de la prevención, tratamiento y el control de las enfermedades del sistema estomatognático. Se entrega en la modalidad de oferta presencial (fija o móvil) y en la modalidad de oferta a distancia, según los criterios técnicos y frecuencia que determine la Dirección de Salud Bucal. Esta actividad es realizada exclusivamente por el Cirujano Dentista. Población objetivo (rango etario) Todas las Edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 1231-2021-MINSA

050	**Atención del recién nacido.**
	Definición operacional Comprende el conjunto sistematizado de procedimientos, actividades e intervenciones sanitarias que se realiza desde el momento del nacimiento y durante su permanencia en alojamiento conjunto con la madre hasta el alta, con el propósito de garantizar condiciones óptimas para su adaptación a la vida extrauterina, fortalecer el vínculo afectivo, promover y/o dar continuidad a la lactancia materna, detectar oportunamente signos de alarma, y brindar consejería a la madre sobre cuidados generales del recién nacido y lactancia materna. Población objetivo (rango etario) De 0 a 28 días de nacido Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 545-2024-MINSA
051	**Internamiento del recién nacido con patología no quirúrgica.**
	Definición operacional Es el conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica especializada que se brinda en hospitalización a todo recién nacido que presenta patología que se detectan durante el periodo neonatal, que no requiere de intervención quirúrgica. Población objetivo (rango etario) De 0 a 28 días de nacido Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 545-2024-MINSA
052	**Internamiento con intervención quirúrgica del recién nacido.**
	Definición operacional Es el conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica especializada que se brinda en hospitalización y en centro quirúrgico, a toda recién nacida o nacido con patología quirúrgica. Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva de acuerdo a la complejidad de la patología. Población objetivo (rango etario) De 0 a 28 días de nacido Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 545-2024-MINSA

053	**Tratamiento VIH-SIDA (0-19 años).**
	Definición operacional Comprende el tratamiento con antirretrovirales de pacientes infectados con VIH, según Norma Técnica vigente. Población objetivo (rango etario) De 0 - 19 Años Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.º 035-2026/MINSA
054	**Atención de parto vaginal.**
	Definición operacional Es aquel nacimiento por vía vaginal. Puede ser sin complicaciones (eutócico) o con complicaciones (distócico) pero que termina por vía vaginal. Población objetivo (rango etario) Mujeres de 09 a 60 años Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM. N.° 827-2013/MINSA
055	**Cesárea.**
	Definición operacional Se refiere a la atención de parto por cesárea, que incluye los productos farmacéuticos, insumos y procedimientos necesarios consumidos en la intervención quirúrgica mayor, que consiste en la extracción del feto, placenta y anexos ovulares mediante incisión abdominal (laparotomía) e incisión uterina (histerotomía), indicada cuando el parto vaginal representa riesgo materno y/o fetal o está contraindicado. Población objetivo (rango etario) Mujeres de 09 a 60 años Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM. N.° 827-2013/MINSA
056	**Consulta externa.**
	Definición operacional Brindada por médico y odontólogo, para atender patologías cuya solución es ambulatoria y que es ofrecida por el establecimiento de salud. Incluye medicamentos, insumos y otros procedimientos utilizados en la prestación. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** D.S. N.° 013-2006-SA

057	**Restauración dental simple (Obturación y curación dental simple).**
	Definición operacional Prestación realizada por el Cirujano Dentista que consiste en la reconstrucción de un diente para restaurar su anatomía, fisiología y estética que han sido afectadas por caries, traumatismos, erosión, abrasión u otros problemas o defectos congénitos y lograr prevenir lesiones futuras. Se considera una sola superficie dentaria afectada. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM 422-2017-MINSA, RM 859-2024- MINSA
058	**Restauración dental compuesta (Obturación y curación dental compuesta).**
	Definición operacional Prestación realizada por el Cirujano Dentista que consiste en la reconstrucción de un diente para restaurar su anatomía, fisiología y estética que han sido afectadas por caries, traumatismos, erosión, abrasión u otros problemas o defectos congénitos y lograr prevenir lesiones futuras. Se considera dos o más superficies dentarias afectadas. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM 422-2017-MINSA, RM 859-2024- MINSA
059	**Extracción dental (exodoncia).**
	Definición operacional Prestación realizada por el Cirujano Dentista que consiste en la remoción quirúrgica de la pieza dentaria afectada en su vitalidad, función y capacidad de restaurar, con la finalidad de eliminar el foco infeccioso. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 422-2017/MINSA

061	**Atención en tópico.**
	Definición operacional Es la prestación recuperativa realizada de manera ambulatoria en los tres niveles de atención que comprende procedimientos que se relacionan directamente a una atención inicial del paciente en Consulta Externa o Emergencia. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03
062	**Atención por emergencia o urgencia.**
	Definición operacional Se refiere a la atención brindada al paciente que ingresa por emergencia o urgencia y que no requiere observación, incluyendo el registro de los daños conforme a la clasificación de prioridad de atención establecida para la prestación. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** NTS Nº 042-MINSA/DGSP-V.01
063	**Atención por emergencia con observación.**
	Definición operacional Se refiere a la atención brindada al paciente que ingresa en situación de emergencia y que requiere observación, incluyendo el registro de los daños conforme a la clasificación de prioridad de atención establecida para la prestación. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** NTS Nº 042-MINSA/DGSP-V.01

064	**Intervención médico-quirúrgica ambulatoria.**
	Definición operacional Prestación de salud médico quirúrgica que se brinda a un paciente en una Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) Centro Quirúrgico, para cuya recuperación y permanencia postoperatoria no requiere pernoctar en el establecimiento de salud. El paciente sale de alta el mismo día del procedimiento. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** NTS N°101-MINSA/DGSP-V.01
065	**Internamiento en establecimiento de salud sin intervención quirúrgica.**
	Definición operacional Es la atención médica no quirúrgica brindada en establecimientos de salud con internamiento a pacientes agudos o crónicos cuya condición o complicaciones requieren hospitalización por un periodo superior a 24 horas, con permanencia y necesidad de soporte asistencial, incluye durante la estancia, los medicamentos, insumos y procedimientos realizados. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** D.S. N.° 013-2006-SA
066	**Internamiento con intervención quirúrgica menor.**
	Definición operacional Es una prestación de salud médico-quirúrgica brindada a un paciente, cuya patología o complicación requiere la realización de una cirugía menor y demanda internamiento pre y postoperatorio por un periodo superior a 24 horas para su recuperación y permanencia postquirúrgica; incluye durante la estancia, los medicamentos, insumos y procedimientos realizados. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** NTS N°101-MINSA/DGSP-V.01

067	**Internamiento con intervención quirúrgica mayor (no cesárea).**
	Definición operacional Es la atención médica quirúrgica, de un asegurado con complicaciones o patología cuya solución requiere de una cirugía mayor (excepto cesárea) con internamiento por un periodo superior a 24 horas. incluye durante la estancia, los medicamentos, insumos y procedimientos realizados. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** NTS N°101-MINSA/DGSP-V.01
068	**Internamiento con Estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).**
	Definición operacional Corresponde al internamiento de un asegurado con estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Incluye materiales, insumos, procedimientos y medicamentos durante la estancia. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 115-2026/MINSA
069	**Transfusión sanguínea o hemoderivados.**
	Definición operacional La transfusión sanguínea es un procedimiento médico terapéutico que involucra procedimientos e insumos necesarios para la obtención, tamizaje, conservación y transfusión por cada unidad de Sangre, de acuerdo con la normatividad vigente. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** Manual de TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

070	**Atención odontológica especializada.**
	Definición operacional Conjunto de procedimientos estomatológicos especializados que se entregan según necesidad individual de la persona. Se realiza en la modalidad presencial en oferta fija y/o móvil y en la modalidad a distancia de corresponder de acuerdo al procedimiento. Realizado Se realiza con la finalidad de restablecer la salud del sistema estomatognático y en la salud general. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 1231-2021-MINSA
071	**Apoyo al diagnóstico.**
	Definición operacional Se refiere al conjunto de procedimientos que se brindan en los Servicios Médicos de Apoyo (UPSS Patología Clínica, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes y otros que se implementen según normativa) para coadyuvar en el diagnóstico médico - quirúrgico (en ese caso se considera prestación recuperativa) o que forman parte de los procesos de atención integral de salud determinados por norma (en ese caso se considera prestación preventiva). Incluye también las actividades de apoyo al diagnóstico de los establecimientos que carecen de Servicios Médicos de Apoyo (pruebas rápidas, ecografía, radiología y otros que puedan implementarse según normativa vigente). Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03

074	**Prevención, detección y tratamiento de ITS en adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores (Tratamiento de ITS en adolescentes, adultos y adultos mayores).**
	Definición operacional Conjunto de actividades y procedimientos establecidos por la normativa vigente, orientados a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes, adultos y adultos mayores. Incluye la realización de consejerías para la prevención del contagio de ITS, pruebas rápidas para su detección y el tratamiento correspondiente. Población objetivo (rango etario) Adolescentes, adultos y adultos mayores Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** R.M. N.° 263-2009-MINSA
075	**Atención extramural en zona rural (visita domiciliaria: recuperativo y/o preventivo).**
	Definición operacional Comprende actividades preventivo – promocionales y recuperativas, fuera del establecimiento de salud, realizada en el domicilio del asegurado, de acuerdo con normas del MINSA. El domicilio se encuentra en zona rural. Se considera como prestación preventiva a las actividades realizadas en el domicilio de un asegurado sano (CIE 10 Z74.2 o Z74.3) y prestación recuperativa cuando la atención se realiza al asegurado en condición de riesgo o morbilidad (Otros CIE 10). Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 834-2019- MINSA.
908	**Atención Domiciliaria.**
	Definición operacional Prestaciones de salud brindadas por el profesional de salud en el domicilio del asegurado para el seguimiento de pacientes crónicos en domicilio a solicitud del médico tratante. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 834-2019- MINSA

060	**Atención extramural en zona urbana y urbana marginal (visita domiciliaria: recuperativo y/o preventivo).**
	Definición operacional Comprende actividades preventivo – promocionales y recuperativas, efectuadas en el domicilio del asegurado, de acuerdo a normas del MINSA. El domicilio se encuentra en zona urbana o urbano marginal. Se considera como prestación preventiva a las actividades realizadas en el domicilio de un asegurado sano (CIE 10 Z74.2 o Z74.3), y prestación recuperativa cuando la atención se realiza al asegurado en condición de riesgo o morbilidad (Otros CIE 10) Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 834-2019- MINSA
901	**Apoyo al Tratamiento.**
	Definición operacional Es el conjunto de procedimientos asistenciales que complementan la atención médica. Las prestaciones de apoyo al tratamiento serán realizadas en aquellos establecimientos que cuentan con la capacidad operativa para ello. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03
906	**Consulta Externa por Profesional no médico ni odontólogo.**
	Definición operacional Se refiere a la consulta ambulatoria preventiva o recuperativa realizada por los profesionales de salud no médicos ni odontólogos (psicólogo, nutricionista u otro según norma) realizado a los asegurados. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** Ley N° 26842

200	**Atención de Rehabilitación.**
	Definición operacional Prestación que cubre los procedimientos de rehabilitación en el I nivel de atención y II con población adscrita, según lo dispuesto por normas específicas en los niveles que corresponda. Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente**: Ley N° 29973
900	**Prótesis dental removible (Rehabilitación protésica).**
	Definición operacional Conjunto de procedimientos realizados según necesidad individual de la persona, mediante aparatos protésicos intraorales con el fin de restablecer la función masticatoria y fonética por ausencia parcial o total de piezas dentarías, en la etapa de vida del adulto mayor en los tres niveles de atención. Población objetivo (rango etario) De 60 años a mas Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N.° 1231-2021-MINSA
300	**Telemedicina.**
	Definición operacional Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, prestados por personal de salud que utiliza las TIC, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I, II y III nivel de atención Población objetivo (rango etario) Todas las edades Normativa **Base:** R.M. N.° 226-2011-MINSA; R.J. N.° 001-2018-SIS/J **Vigente:** RM N° 664-2025-MINSA

301	**Cuidado Integral por curso de vida del Niño.**
	Definición operacional Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral en el niño y niña; a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, orientadas al bienestar físico y mental, el desarrollo cognitivo, psicomotor, emocional, afectivo y social, así como, reducir la morbilidad y mortalidad infantil. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención Población objetivo (rango etario) De 0 a 11 años 11 meses y 29 días. Normativa **Base:** RM. Nº 030-2020-MINSA **Vigente:** RM. Nº 682-2025-MINSA
302	**Cuidado Integral por curso de vida del Adolescente.**
	Definición operacional Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral del adolescente; a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, dirigidas al desarrollo físico, maduración mental, desarrollo intelectual, desarrollo emocional y desarrollo social. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Población objetivo (rango etario) De 12 a 17 años 11 meses y 29 días. Normativa **Base:** RM. Nº 030-2020/MINSA **Vigente:** RM. Nº 1001-2019/MINSA

303	Cuidado Integral de la salud por curso de vida del Joven.
	Definición operacional Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral del joven; a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, identificando precozmente los factores y conductas de riesgo, así como los problemas de salud; orientadas al desarrollo físico, maduración mental, desarrollo intelectual, desarrollo emocional y desarrollo social. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Población objetivo (rango etario) De 12 a 17 años 11 meses y 29 días. Normativa **Base:** RM. Nº 030-2020/MINSA **Vigente:** RM. Nº 944-2012/MINSA
304	**Cuidado Integral de la salud por curso de vida Adulto.**
	Definición operacional Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral en el adulto; a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, dirigidas para satisfacer las necesidades de salud que fomenten las conductas de autocuidado, prevención y promoción de comportamientos saludables. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Población objetivo (rango etario) De 30 a 59 años 11 meses 29 días. Normativa **Base:** RM. Nº 030-2020/MINSA **Vigente:** RM N°310-2025-MINSA

305	Cuidado Integral de la salud por curso de vida Adulto Mayor.
	Definición operacional Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral en el adulto mayor, a través de estrategias, intervenciones y actividades, en los componentes de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños a la salud, diagnóstico, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos y seguimiento, prestados por el personal de salud, dirigidas para satisfacer las necesidades de salud, reduciendo los periodos de enfermedad y promoviendo su autonomía e independencia. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención Población objetivo (rango etario) De 60 años a más. Normativa **Base:** RM. Nº 030-2020/MINSA **Vigente:** RM N°789-2023-MINSA
306	**Cuidado Integral de la salud Prenatal.**
	Definición operacional Prestaciones de servicios de salud, para la atención integral de la gestante (durante el embarazo, parto y puerperio), a través de intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, prestados por el personal de salud, orientadas a lograr el bienestar físico y mental, emocional, afectivo y social, así como, reducir la morbilidad y mortalidad. Este servicio puede ser registrado por los establecimientos del I Nivel de atención. Población objetivo (rango etario) Mujer gestante (durante el embarazo, parto y puerperio). Normativa **Base:** RM. Nº 030-2020/MINSA **Vigente:** RM. Nº 007-2017/MINSA